

2

ALTERACIONES DEL SUEÑO DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA

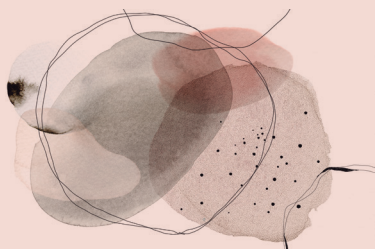
// DRA MARÍA ELENA MAZZOLA*

Neuropediatra.

Jefa de la Unidad de Medicina de Sueño de FLENI.

Ex Presidenta de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



JUANA, 9 MESES

Juana es la primera hija de una pareja, es sana, nacida a término, sin antecedentes de trascendencia, cuyos padres consultan porque refieren que nunca durmió una noche en forma ininterrumpida.

Interrogando sobre las rutinas de sueño, mencionan que se duerme con un biberón y luego la acuestan en su cuna. Allí permanece durante unas tres horas dormida y luego despierta con llanto. No vuelve a conciliar el sueño sino es con otro biberón.

Este patrón se repite todos los días, con dos o tres despertares nocturnos. En las siestas, la niña concilia el sueño del mismo modo. Es muy activa durante el día y su temperamento es bastante irritable.

¿Cuál es la primera presunción diagnóstica?
¿Qué conducta debe tomarse con esta familia?

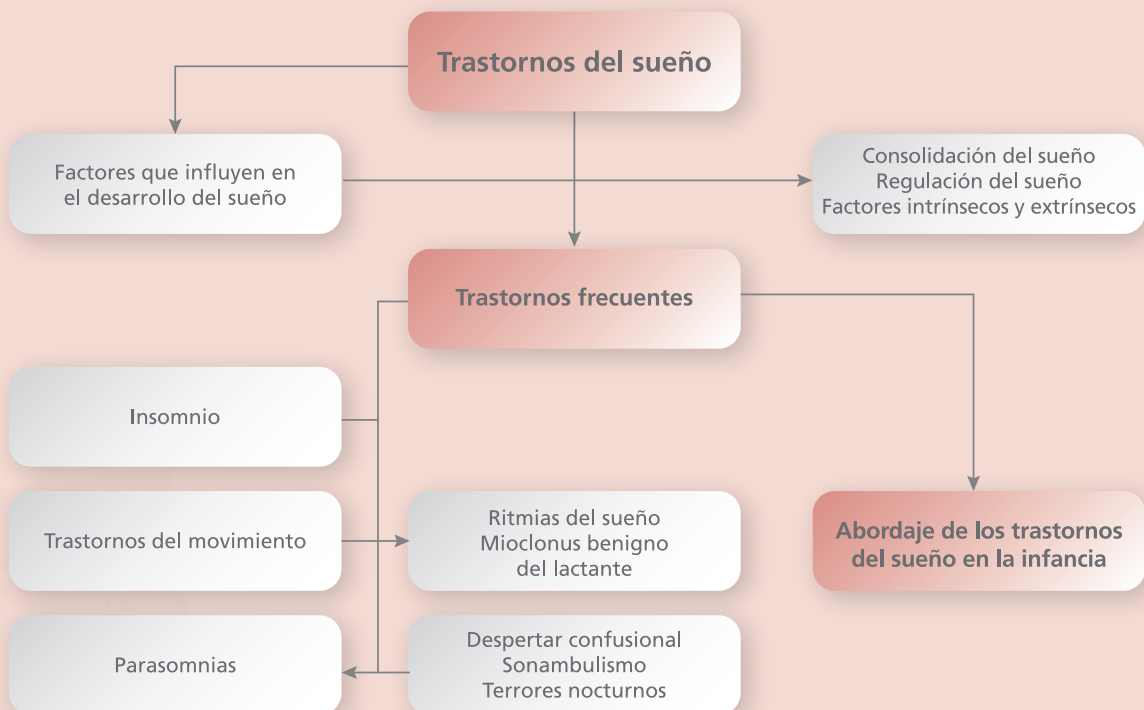


OBJETIVOS

- ◆ Recordar la frecuencia y clasificación de los trastornos del sueño en los primeros años de vida.
- ◆ Identificar los diferentes factores que influyen en el desarrollo del sueño.
- ◆ Describir los trastornos de sueño más frecuentes en la infancia.
- ◆ Reconocer el origen multifactorial de las alteraciones del sueño.
- ◆ Realizar diagnóstico, tratamiento y/o derivación al especialista.
- ◆ Orientar a las familias sobre las buenas prácticas relacionadas con el sueño de los niños.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

Alteraciones del sueño durante los dos primeros años de vida

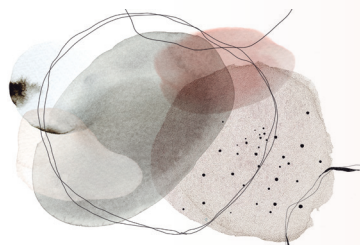


INTRODUCCIÓN

Los trastornos del sueño en la infancia y la adolescencia repercuten en el desarrollo físico, psicológico, social y del aprendizaje. Son motivo frecuente de consulta en pediatría y de allí la importancia de conocerlos.

Durante los primeros años de vida se describen:

- ✓ **Trastornos respiratorios durante el sueño.** Entre los 2 y los 8 años la prevalencia del síndrome de apneas hipopneas obstructivas del sueño alcanza el 2%, incluyendo en este grupo el síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior.
- ✓ **Insomnio.** Su prevalencia depende de su tipo y de la edad del niño, pero en general se estima que es de alrededor del 35%.
- ✓ **Parasomnias** (particularmente las del sueño NO REM). Su frecuencia de aparición según distintas fuentes va desde un 5% para los terrores nocturnos hasta un 16-18% para los despertares confusionales y el sonambulismo.
- ✓ **Trastornos del movimiento asociados al sueño.** Con una prevalencia entre 6 y 60% según la edad, siendo más frecuentes en los más pequeños.



El sueño se define como un proceso fisiológico, dinámico y reversible que involucra a la mayoría de las funciones vitales. Lejos de ser pasivo, es activamente inducido y un estado altamente organizado del cerebro.

La abundante proporción de sueño en la vida fetal y neonatal da cuenta de su vital participación en la maduración y plasticidad cerebral.

A los dos años el niño ha dormido trece meses. Entre los dos y los cinco años pasan la mitad de su día durmiendo. A partir de los seis años y en los adolescentes el sueño ocupa el 40% del día y en el adulto el 33%.

A lo largo de la vida disminuye no sólo su proporción en las veinticuatro horas, sino que se modifica su calidad y su distribución.

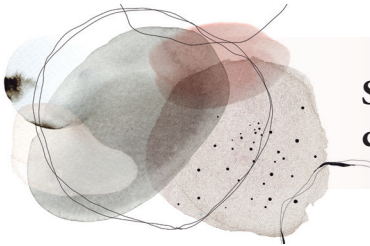
Según la Academia Americana de Medicina del Sueño (AASM) en su tercera edición, **los trastornos del sueño se clasifican en:**

- ✓ Insomnios.
- ✓ Trastornos respiratorios del sueño.
- ✓ Hipersomnias centrales.
- ✓ Trastornos del ritmo circadiano.
- ✓ Parasomnias.
- ✓ Trastornos del movimiento asociados al sueño.

En este capítulo no se tratarán los trastornos respiratorios durante el sueño ya que han sido motivo de otra publicación.

FRECUENCIA DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO

Según distintas fuentes, un 30% de los niños entre seis meses y cinco años tiene trastorno con su sueño.



Sólo se entiende que un trastorno es tal si ocasiona consecuencias en la calidad de su vigilia.

Teniendo claro este concepto, un lactante que se alimenta por las noches varias veces sin que ello lo afecte durante el día, no debería considerarse como un trastorno del sueño.

En su mayoría tienen un origen conductual, mientras **sólo en un 5% de los casos existen causas médicas** subyacentes (el síndrome de piernas inquietas, los trastornos respiratorios durante el sueño, el reflujo gastroesofágico, la alergia a la leche de vaca, entre otros).

Otras publicaciones mencionan que un 25% de los niños tiene trastornos del sueño en algún momento de su vida, mientras que asciende al 40% en los adolescentes.

Si se toman en cuenta las poblaciones especiales (niños con retardo mental, trastornos del espectro autista, etc.) las alteraciones del sueño alcanzan el 60 al 80%. Dentro de las patologías del dormir es el insomnio la que prevalece en los niños con trastornos psiquiátricos o del neurodesarrollo.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL SUEÑO

Durante los dos primeros años de vida los patrones de sueño vigilia cambian drásticamente.

Una forma de analizar los cambios evolutivos del dormir es a partir de comprender la existencia de dos procesos fundamentales: la consolidación y la regulación del sueño.

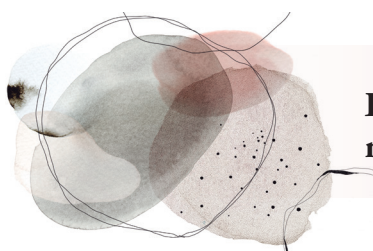
Consolidación del sueño

La consolidación hace referencia a la emergencia del ciclo circadiano (ciclo de alrededor de veinticuatro horas, cuyo representante más conspicuo es el sueño vigilia).

En el momento del nacimiento los ciclos de sueño vigilia se encuentran relacionados y regulados especialmente por los periodos hambre-saciedad. Duran menos de veinticuatro horas y se llaman ritmos ultradianos. Normalmente un recién nacido sano cumple entre cinco a seis ciclos (hambre-vigilia, saciedad-sueño) durante las veinticuatro horas. Los lactantes alimentados a pecho suelen tener periodos más breves, ya que la leche materna se digiere más rápidamente que la de fórmula.

Como ya se señaló, la proporción del sueño en el día va disminuyendo paulatinamente. Al finalizar el primer año, un niño duerme entre doce y trece horas (un 50% del día) que se consolidan en un extenso periodo de sueño nocturno y una o dos siestas diurnas.

A los tres años el niño duerme entre once y trece horas.



El sueño no se considera consolidado totalmente sino hasta el momento en que han desaparecido las siestas.

Esta situación ocurre a más tardar a los siete años, pero comienza a partir de los cuatro. Su persistencia más allá de esta edad sugiere un sueño nocturno poco eficiente, breve, de mala calidad o interrumpido, de manera que ante esta situación el pediatra debe estar alerta.

Regulación del sueño

Dormir a lo largo de la noche representa un importante hito madurativo: significa que el lactante es capaz de conciliar y mantener el sueño de forma independiente.

Muchos padres van a la consulta del pediatra creyendo que su hijo no duerme lo suficiente. Un modo de evaluar la presencia o no de un trastorno del sueño es a través de un diario o calendario de sueño. Es de fácil confección y los padres deben completarlo durante al menos quince días consecutivos. No es de extrañar que muchos se sorprenden cuando observan gráficamente tanto la cantidad total de horas de sueño como su distribución. No olvidemos, por otra parte, que cierta fragmentación del sueño es normal.

Entre el 80 y el 95% de los niños de un año tienen un sueño más o menos ininterrumpido. Los pequeños con mejor regulación presentan un sueño más continuo en comparación con aquellos que requieren de la intervención externa para la conciliación (mecarlos, contacto físico estrecho, biberón o pecho, etc.).

Si nos preguntamos si la consolidación precede a la regulación o viceversa, la respuesta es difícil de dar. Probablemente un lactante que se autorregule podrá realizar la consolidación más fácilmente que otro que no lo logra.

Factores intrínsecos y extrínsecos

Los **factores intrínsecos** son aquellos que dependen del individuo. En relación con el sueño, se incluyen las características del temperamento y la reactividad fisiológica.

Factores perinatales (tabaquismo, prematurez, bajo peso, exposición al alcohol, entre otros) podrían influir en el desarrollo del temperamento. Algunas investigaciones relacionan la irritabilidad con problemas del sueño.

En cuanto a la reactividad fisiológica, altos niveles de cortisol podrían ser una manifestación de hiperreactividad autonómica simpática en niños con trastornos del sueño. La arritmia sinusal (bradipnea espiratoria y taquipnea inspiratoria) por el contrario, indicaría una mejor regulación autonómica.

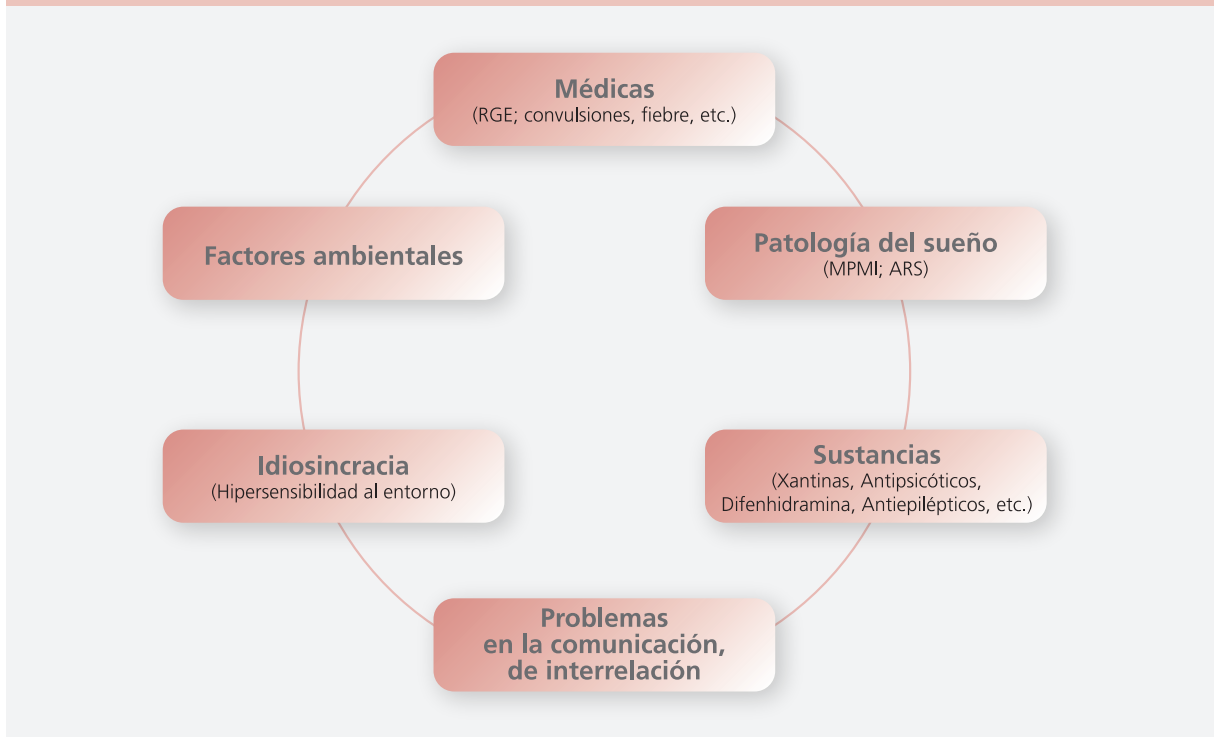
Se postula que el funcionamiento del sistema nervioso autónomo (SNA) y el sueño se hallan íntimamente relacionados. Lactantes fisiológicamente más reactivos presentan un aumento de la tendencia al despertar a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal y consecuentemente más dificultades para conciliar el sueño.

Dentro de los **factores extrínsecos** el principal, sin lugar a duda, es el accionar parental. Depende del grado de conocimiento de las buenas prácticas del sueño y es el pediatra el agente de educación en este proceso.

Los niños que son puestos en su lecho dormidos, aquellos que son alimentados por la noche, los que hacen colecho y los que se duermen con contacto físico estrecho se despiertan más cantidad de veces y con mayor facilidad durante las noches.

Las alteraciones del sueño tienen un origen múltiple; hay factores que dependen del individuo y de su idiosincrasia (como la hipersensibilidad a los estímulos externos, muy importante en los niños que padecen TEA), factores del medio ambiente (luz, temperatura, ruidos, etc.), la eventual presencia de enfermedades concurrentes (del sueño o no), de la interrelación del niño con el cuidador, del grado de comprensión del pequeño cuando se le administran pautas para la higiene del sueño, el consumo de fármacos o sustancias excitantes (cafeína, anticonvulsivantes, etc.).

La mala calidad de sueño durante el primer y el último trimestre del embarazo se asocia a nacimientos prematuros. El estrés fisiológico del embarazo produce fragmentación del sueño y a su vez, una respuesta inflamatoria exagerada. Una de sus causas puede ser la existencia de impaciencia de miembros inferiores (referida por el 30% de las embarazadas durante el tercer trimestre), que puede o no estar asociado a la presencia de movimientos periódicos de miembros inferiores durante el sueño.

Figura 1. Origen multifactorial de los trastornos del sueño

RGE: reflujo gastroesofágico; MPMI: movimientos periódicos de miembros inferiores; ARS: alteraciones respiratorias durante el sueño.

TRASTORNOS DEL SUEÑO MÁS FRECUENTES EN LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

1. Insomnio

El insomnio es la dificultad permanente relacionada con la iniciación (considerando en los niños la incapacidad de hacerlo por sus propios medios), duración, consolidación o calidad del sueño, que aparece a pesar de darse las condiciones adecuadas y que acarrea algún tipo de consecuencias en la vida diurna (Clasificación Internacional de los trastornos del sueño-CITS). Esta clasificación, en el cuerpo explicativo del insomnio refiere que puede verse a partir de los seis meses de vida, atendiendo a que luego de esa edad requieran de la intervención del adulto para la conciliación, sólo si y siempre que esta particularidad como consecuencias alteraciones en la vida diurna (irritabilidad, hipersomnias y en niños mayores alteraciones en el rendimiento académico, etc.). Si no las hay, no cabe la definición de insomnio.

El dormir de manera continua durante la noche es un logro adquirido a lo largo del tiempo que puede perderse por diversas circunstancias.

Uno de cada tres niños sanos se despierta por las noches. Despertares breves son normales en todas las edades. Sólo afectan la calidad de la vida diurna si tienen una duración superior a los 20 minutos tanto en niños como en adultos.

El **criterio diagnóstico** más específico del insomnio pediátrico es no poder conciliar el sueño por sus propios medios.

Debe asociarse a repercusión sobre la vida diurna como fatiga, alteraciones de la atención, conducta, humor, del rendimiento escolar, social o familiar. Su consecuencia, la somnolencia diurna excesiva, predispone a accidentes, ya que suele manifestarse con un aumento de la actividad motora que el niño muestra para vencer el sueño.

Las quejas, provenientes usualmente de los padres, no pueden explicarse por falta de oportunidad o por circunstancias inadecuadas para dormir.

En el caso del **insomnio crónico** estas características deben presentarse al menos tres veces por semana durante tres meses.

Entre los **factores condicionantes y desencadenantes del insomnio** se señalan:

- ✓ **Factores relacionados con el ritmo circadiano.** El momento en que comienza la secreción de melatonina (Dim Light Melatonin Onset: DLMO) precede aproximadamente dos horas al inicio del sueño. La DLMO se encuentra entre las 18 y las 21 h en los niños entre 0 y 9 años, más temprana cuanto menor es. Como ejemplo: al año de vida debería comenzar a disponerse a dormir alrededor de las 20 h. Los niños que son obligados a dormir en un horario muy cercano a la secreción de esta hormona presentan latencias de sueño más prolongadas y mayor resistencia a conciliar el sueño.
- ✓ **Factores homeostáticos.** Una mayor proporción de horas de sueño durante el día, reducen la presión homeostática del sueño, por lo que no se recomiendan siestas demasiado prolongadas ni, en general, posteriores a las 17 h. Estas medidas facilitan la conciliación y la continuidad nocturna.
- ✓ **Factores ambientales.** Más allá de los clásicos (ruidos, luz, temperatura) la exposición a las pantallas (tablets, celulares, computadoras, etc.) antes de dormir retrasa y reduce la secreción de melatonina, que en los niños puede llegar a ser un 80% menor.
- ✓ **Educación.** A través de la información sobre el sueño y las buenas prácticas, se educa a los cuidadores en la atención primaria (evitar rutinas inapropiadas, horarios irregulares, siestas en momentos inoportunos, etc.).
- ✓ **Endócrino.** El déficit de sueño favorece niveles vespertinos elevados de cortisol. El estrés materno durante el tercer trimestre del embarazo favorece la permeabilidad de la placenta a los corticoides y condiciona un incremento de dichas hormonas en el feto, retraso en la aparición del ritmo circadiano diurno de cortisol, y una hiper-respuesta hipotálamo-gonadal a situaciones de estrés.
- ✓ **Psicológicos.** La depresión materna, los trastornos del desarrollo y los problemas vinculares influyen sobre el sueño.

Figura 2. Factores condicionantes y desencadenantes de insomnio

Formas de presentación clínica de insomnio en los primeros años

a. Malas asociaciones del sueño

Tiene lugar en niños que relacionan el sueño con objetos o circunstancias que, si no aparecen en el momento de dormir, les crea ansiedad y temor. Debe quedar en claro que durante los primeros 6 meses de vida no se establecen buenas o malas asociaciones del sueño. Es conveniente comenzar a establecer rutinas; por ejemplo, bañarlo, ponerle la ropa con la que va a dormir, lavarle los dientes, tomar agua. Ya en la cama leer un cuento o contar una historia, con su objeto transicional, para luego despedirse y asegurarle que se estará atento a lo que necesite pero que es necesario que a esa hora descanse. Es aconsejable dejar una luz tenue en el cuarto o en el pasillo para que, en los despertares fisiológicos y habituales que transcurren por la noche, el niño se encuentre ubicado. Se conoce como pausa nocturna al periodo de sueño nocturno más prolongado (consolidación del sueño señalada más arriba).

b. Falta de límites

Ocurre en niños cuyos padres colocan límites y reglas inconsistentes o poco claras tanto de día como de noche. Son frecuentes en pequeños en edad preescolar, escolar y en familias de niños crónicamente enfermos.

c. Mala higiene del sueño

Tiene lugar cuando los hábitos de sueño-vigilia son inadecuados. Se incluyen en este apartado las siestas inoportunas (en especial las que tienen lugar después de las 17 h), el abuso de sustancias estimulantes (caféina, bebidas cola, chocolates, comidas ultra procesadas) y el uso de pantallas antes de dormir, así como los horarios de sueño y vigilia irregulares.

Provocan una disminución del tiempo de sueño y somnolencia diurna excesiva que rara vez se manifiesta con los síntomas clásicos del adulto. Sí, en cambio son más frecuentes la irritabilidad, la hiperactividad y la inatención.

d. Insomnio psicofisiológico

En general ocurre en niños mayores y adultos. Para su aparición confluyen ciertos factores de riesgo (vulnerabilidad genética, comorbilidades psiquiátricas), precipitantes (estrés) con otros (mala higiene del sueño, etc.). Su característica principal es un estado de hipervigilancia y una preocupación excesiva por no poder dormir generada a partir de un determinado evento que provocó insomnio. Se ve en niños mayores y en adolescentes, no en el grupo etario tratado en este capítulo.

e. Cólicos del lactante

Wessel los llamó “cólicos de los tres meses”, haciendo referencia al lactante entre los quince días y los tres meses de vida cuando llora más de tres horas por día, durante más de tres días por semana, durante más de tres semanas consecutivas. No hay maniobra alguna que logre calmarlo. El cuadro no tiene diferencias en su presentación según etnias, sexo o clases sociales. Una teoría los relaciona con la falta de producción de melatonina y con alteraciones en la secreción de cortisol.

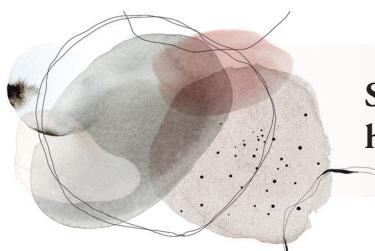
En el recién nacido (RN) la melatonina proviene de la que ha recibido por vía transplacentaria y luego, de la leche materna (manteniendo el ritmo circadiano de secreción materno). Se conoce su efecto relajante sobre la musculatura gastrointestinal, por lo que se infiere que bajos niveles de melatonina podrían estar involucrados en estas manifestaciones gastrointestinales.

La producción endógena de melatonina comienza después de los tres meses, época en que los cólicos comienzan a mejorar. Es secretada por la glándula pineal, células del tracto gastrointestinal, la piel, la retina y los órganos linfoides. Entre los tres y los siete años encuentra su pico de secreción. En la pubertad se produce una disminución relativa de su concentración como consecuencia del aumento acelerado del índice de masa corporal. La melatonina inhibe el desarrollo puberal y este descenso relativo interviene en la aparición de madurez sexual. En la adolescencia ocurre un retraso del horario de su secreción y a los treinta años comienza su declinación.

Diagnóstico y tratamiento del insomnio

Para su tratamiento debemos tener presente, en principio, que cumpla con los criterios de la definición.

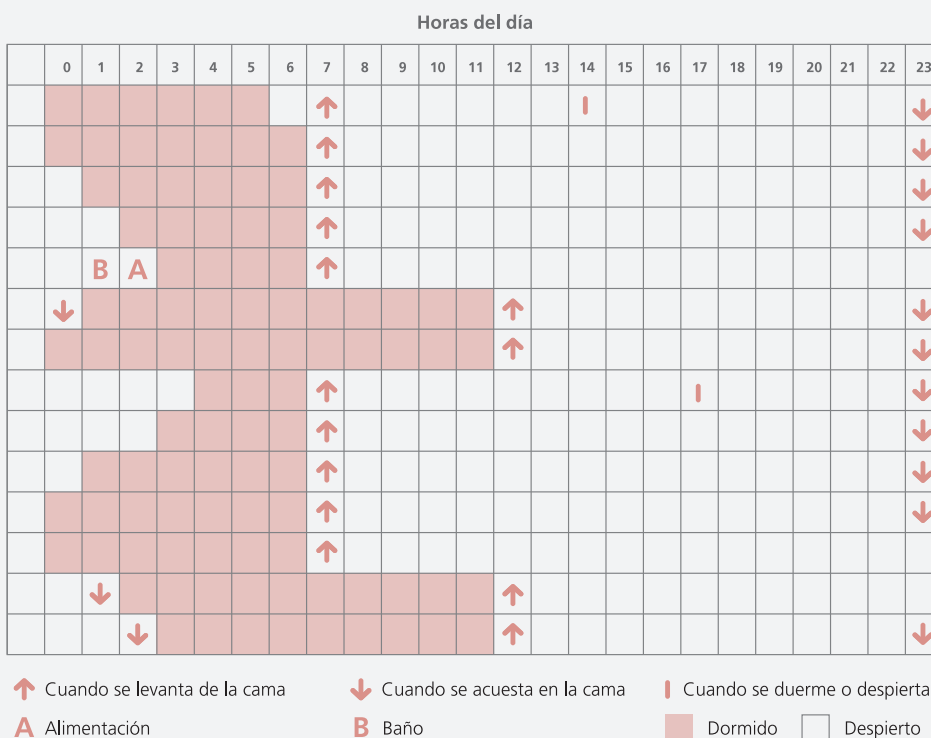
Su evaluación requiere de una anamnesis detallada, que incluya los antecedentes personales y familiares. Un video casero puede aclarar el cuadro. El examen físico puede poner de manifiesto signos que hagan sospechar la existencia de alteraciones respiratorias durante el sueño (hipertrofia amigdalina, retro-micrognatia, respiración bucal, voz nasal, etc.).



Si el insomnio tiene una comorbilidad, lo primero que debe hacerse es tratarla.

En los casos en que el origen sea primario, es de mucha utilidad tanto para el médico como para los cuidadores, la confección una agenda de sueño durante catorce días. El pediatra debe brindarles a los padres la información adecuada sobre el sueño normal a las distintas edades y las medidas adecuadas para implementar una higiene del sueño correcta.

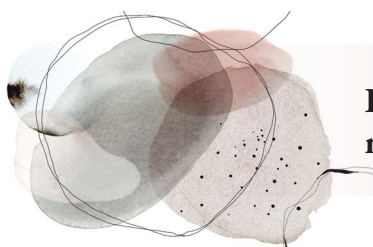
Figura 3. Agenda de sueño



En la agenda, cada casillero representa una hora. Los espacios sombreados son aquellos en los que el niño estuvo dormido y en blanco cuando estuvo despierto. Las flechas señalan posición (acostado hacia abajo y hacia arriba levantado). Se pueden incluir los momentos de baño con una B, de alimentación con una A y cualquier otra cuestión que resulte valiosa para la comprensión de lo que ocurre.

Luego de un periodo a definir según el caso (entre quince días y un mes en general), se vuelve a citar a la familia. Allí se disipan dudas, se evalúan progresos, aciertos y desaciertos. A veces, sólo con estas medidas se puede lograr una mejoría.

De no ser así, se le propondrá a la familia realizar un tratamiento conductual, en lo posible con un profesional entrenado, quien insistirá en las medidas de higiene del sueño, establecimiento de rutinas y quien podrá percibir la existencia de factores emocionales, sociales, culturales, que han pasado desapercibidos.



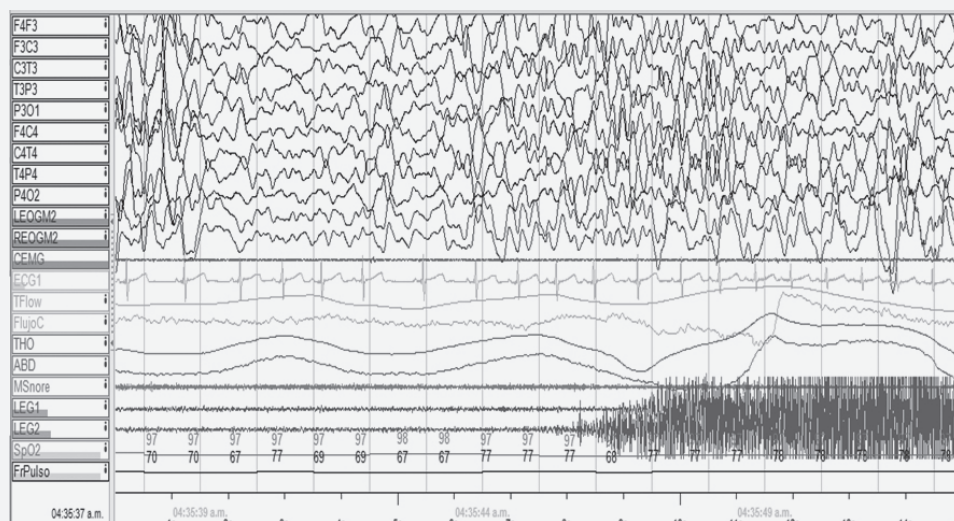
Los tratamientos nunca deben realizarse en menores de seis meses.

Cuando los niños se despiertan por la noche a horarios regulares, algunos autores proponen estimularlos ligeramente (acariciarlos, por ejemplo) unos quince a veinte minutos antes y así evitar que se produzca la vigilia espontánea. Este tipo de intervención es utilizada especialmente en los despertares incompletos ocurridos durante las parasomnias NO REM (que se tratarán más adelante).

El tratamiento del insomnio es más difícil cuando son varios niños viviendo juntos, o en ambientes reducidos, o bien cuando hay vecinos cercanos.

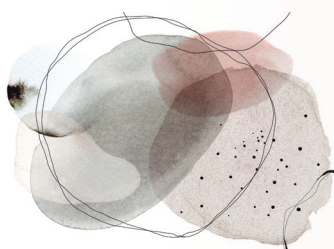
Si el niño no responde es necesaria una reevaluación familiar.

En los casos en los que se tengan dudas diagnósticas o se sospechen factores orgánicos subyacentes que requieran otro tipo de intervención (ejemplos: impaciencia o movimientos periódicos de miembros inferiores, diagnóstico diferencial entre parasomnias NO REM y crisis del lóbulo frontal, síndrome de resistencia aumentada de la vía aérea superior, entre otros) pueden eventualmente solicitarse estudios complementarios. El gold standard para el estudio de los trastornos del sueño es la **polisomnografía nocturna**. Consiste en el registro de una serie de variables fisiológicas en forma continua y conjunta a lo largo de toda la noche (al menos seis horas de registro). Controla la actividad electroencefalográfica, el electromiograma de superficie de mentón y de miembros inferiores, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, el flujo aéreo, la neumografía toraco abdominal.

Figura 4. Registro polisomnográfico

Los ocho primeros canales corresponden al registro electroencefalográfico (permite evaluar etapas de sueño, existencia o no de alteraciones comiciales), LEO y REO: corresponden a los movimientos oculares (que permiten clasificar etapas de sueño y vigilia), EMG: el electromiograma de mentón (permite evaluación de etapas de sueño), ECG: electrocardiograma, T.flow: pasaje de aire por boca, Flujo C: pasaje de aire por nariz, THO: los movimientos torácicos, ABD: movimientos abdominales, Snore: el ronquido, LEG1-LEG2: el electromiograma de miembros inferiores izquierdo y derecho (permite observar la presencia de movimientos periódicos de miembros inferiores), SaO2: la saturación de oxígeno, Fr Pulso: la frecuencia cardíaca.

Este estudio nos permite conocer el tiempo que tarda en dormirse (latencia), la estructura interna del sueño, los despertares existentes y en qué etapas se originan, la eficiencia del dormir, si existen anomalías electroencefalográficas, cardio respiratorias, presencia de movimientos periódicos de miembros inferiores, entre otras.



Sólo en casos en los que los tratamientos conductuales no fueron efectivos, en ausencia de patología, podría plantearse la indicación de medicación por un breve lapso. Este tipo de medida sólo deberá estar a cargo de un especialista en trastornos del sueño.

2. Trastornos del movimiento asociados al sueño

Los principales durante los dos primeros años de vida son las ritmias del sueño y las mioclonías benignas de la infancia.

a. Ritmias del sueño

Durante los primeros años de vida, en periodos de transición sueño-vigilia se pueden observar fenómenos denominados ritmias del sueño. Son movimientos estereotipados, rítmicos, repetitivos y voluntarios, asociados a vocalizaciones o no, que aparecen para “conjurar el sueño” en niños pequeños. Son frecuentes y suelen desaparecer cerca de los cuatro años. Se presentan con mayor asiduidad en niños con alteraciones del neurodesarrollo (síndrome de Down, TEA, etc.).

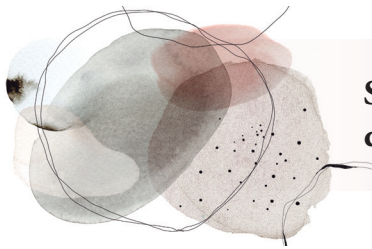
Su prevalencia es de alrededor del 60% durante el primer año de vida.

En su aparición se describen factores predisponentes (como la estimulación vestibular) y factores desencadenantes (estrés, falta de estímulos). Se observan más especialmente durante la conciliación y en etapas N1 y N2 (sueño superficial). Se advierten también en los despertares a lo largo de la noche.

Pueden ser clasificados según la parte del cuerpo y el eje involucrados en:

Head banging	movimiento de cabeza en el eje anteroposterior
Head rolling	movimientos de cabeza en eje latero lateral
Body banging	movimientos de cuerpo en eje anteroposterior
Body rolling	movimientos de cuerpo en eje latero lateral

Raramente pueden afectar una extremidad, por ejemplo, una pierna: leg rolling, leg banging.



Sólo si alteran el sueño o la vigilia se los considera como desordenes del movimiento asociados al sueño.

En los casos de niños mayores, si se les pregunta acerca del motivo por el que realizan dichos movimientos, no saben el por qué, pero sí refieren la necesidad imperiosa de realizarlos. Pueden detenerlos, pero es un impulso difícil de contener.

Hay artículos que relacionan las ritmias con falta de maduración de los centros inhibidores corticales.

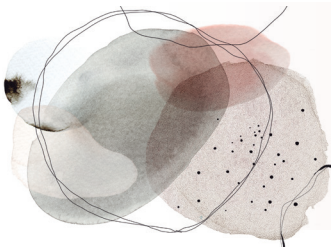
Cuando se prolongan en el tiempo, provocan alteraciones de la vida familiar o son muy intensos, puede indicarse algún tipo de medicación (melatonina, triptófano o clonazepam), aunque no hay estudios bien diseñados que demuestren su eficacia.

b. Mioclonus benigno del lactante

Es un trastorno raro del movimiento. Su principal importancia radica en que puede confundirse con una encefalopatía grave que se presenta a la misma edad.

Se trata de la aparición de mioclonías en forma repetitiva que involucran a los miembros, el tronco o todo el cuerpo. Tienen lugar hasta los seis meses y sólo ocurren durante el sueño (a diferencia de las crisis epilépticas). Cesan abruptamente cuando el lactante se despierta o si se toma la extremidad del niño. No se explican por otra causa. Los lactantes son sanos, aunque han sido descritas en recién nacidos de madres que consumen opioides, como resultado de un síndrome de abstinencia.

La prevalencia es desconocida. La incidencia ha sido estimada entre el tres y diez mil nacidos vivos. Los niños están más afectados que las niñas en una relación de dos a uno. Como factores desencadenantes se señalan los ruidos y los estímulos intensos.



Su evolución es autolimitada. La duración es entre los quince y los treinta y cinco días. El 60% de los casos se encuentra resuelto a los seis meses de vida y no se describen secuelas.

En el caso de estudiarse el sueño, suelen tener lugar en Sueño NO REM. Se ha supuesto que su origen es subcortical debido a que el electroencefalograma es normal.

Pueden manifestarse mientras se mece al lactante y esta maniobra se utiliza para realizar el diagnóstico diferencial con epilepsia en el transcurso de un registro electroencefalográfico.

En el síndrome de West, una encefalopatía grave cuyas crisis se denominan “espasmos en flexión”, las mioclonías aparecen en vigilia y desaparecen en sueño. El registro electroencefalográfico patológico es característico y se denomina hipsarrítmia.

3. Parasomnias

Se describen como eventos físicos o experiencias indeseadas que pueden provocar alteraciones en la arquitectura del sueño y secundariamente insomnio o somnolencia diurna excesiva.

Se dividen según la etapa de sueño en la que aparecen, en parasomnias REM y NO REM. Dentro de las asociadas al sueño REM se describen el trastorno conductual del REM, las pesadillas recurrentes y la parálisis del sueño aislada recurrente.

Las parasomnias NO REM son las que predominan en la infancia y a este tipo me referiré en este apartado. Su prevalencia varía entre el 1 y el 4% de la población.

Son desórdenes del despertar e incluyen:

a. Despertares confusionales.**b. Sonambulismo.****c. Terrores nocturnos.**

La sexsomnia y el desorden de ingesta relacionada al sueño forman parte de las parasomnias NO REM, pero no ocurren en los niños.

Los tres primeros presentan patrones familiares y mecanismos fisiopatológicos similares. Se diferencian entre sí por la duración, complejidad, tipo de conducta, así como el grado de amnesia posterior.

a. Despertar confusional

Se presenta en cerca del 4% de los niños y niñas. Está caracterizado por la aparición de actividad motora simple a partir de un despertar incompleto. El niño puede incorporarse en su cama, pero no deambular, vocalizar, no tiene facies de terror, ni existe mayor descarga autonómica. En general son breves (alrededor de cinco minutos) y se retorna al sueño pacíficamente. De todas las parasomnias NO REM suelen ser las más cortas.

b. Sonambulismo

En este caso el comportamiento a partir del despertar es complejo, con deambulación y acciones que remedan a las normales del día (acariciar a la mascota, orinar, pero en el lugar equivocado, abrir puertas, etc.). Los movimientos se realizan en ausencia de conciencia del medio. Típicamente, en el caso de poder responder, el niño no recuerda lo sucedido por la mañana, aunque en los más pequeños el interrogatorio es difícil de hacer. Intentar despertarlo prolonga el episodio. El sonambulismo puede ser prolongado, habitualmente no se acompaña de actividad autonómica exagerada y en ocasiones puede incluir un comportamiento peligroso.

Su frecuencia de aparición es entre el 1 y el 16% de la población y se advierte una clara incidencia familiar.

Puede ser que se asocie a expresión de temor, en estos casos se llama sonambulismo-terror y proviene de la asociación de dos tipos de parasomnias NO REM.

c. Terrores nocturnos

Se observa en el 5% de los niños. Son episodios de despertar incompleto con muestras externas de intenso terror, gritos y descarga autonómica exacerbada (dilatación pupilar, taquicardia, taquipnea, sudoración, temblor). Sin respuesta o con escasa respuesta al medio, en estos casos los pequeños se muestran inconsolables. Pueden durar más de cinco minutos y los intentos de intervenir para despertarlos causan mayor agitación.

Fisiopatogenia

Habitualmente un despertar se realiza en forma paulatina desde etapas profundas NO REM, pa-

sando por superficiales hasta llegar a la vigilia. Los despertares incompletos pueden ser consecuencia de procesos que profundizan el sueño e impiden un despertar completo, o bien por la presencia de una patología que provoca micro despertares corticales periódicos con la consecuente fragmentación (trastornos respiratorios durante el sueño, movimientos periódicos durante el sueño, ruidos, narcolepsia).

En las parasomnias NO REM (especialmente en el sonambulismo), se señalan factores predisponentes genéticos y familiares. Se describe una alta prevalencia de HLA DQB1 * 05:01 y DQB1 * 04.

Se postula que los comportamientos complejos con amnesia posterior están originados en la activación del centro generador de patrones arcaicos con un relativo aislamiento del control del lóbulo frontal (funciones ejecutivas) y del límbico (recuerdos) que originarían la amnesia relativa que los caracteriza.

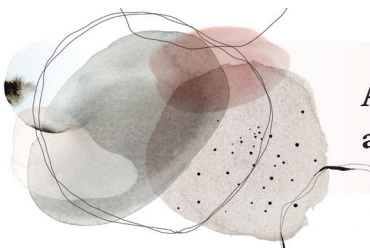
Las parasomnias NO REM predominan en la primera mitad de la noche, periodo en el que tiene lugar la mayor proporción de sueño de ese tipo.

El marco de referencia teórico para la aparición de las parasomnias NO REM se basa en la coexistencia de áreas de vigilia de la corteza motora y en el área cingulada, que coexisten junto a otras de sueño en las regiones corticales asociativas.

Se describe en ellas un carácter madurativo, ya que suelen remitir en forma espontánea con el crecimiento.

Pueden tener lugar varias en un mismo individuo.

Tratamiento de las parasomnias NO REM



A los padres se les aconseja no intervenir, sino tener una actitud expectante por si conllevan riesgo.

Si se presentan en forma aislada, no requieren de ninguna intervención médica. Si ocurren con frecuencia deben descartarse causas subyacentes, tanto de orden psicológico como médico.

En caso de pensar en la existencia de un mecanismo desencadenante, por ejemplo, que las parasomnias estuvieran desencadenadas por la presencia de movimientos periódicos de miembros inferiores, es de utilidad solicitar niveles de ferritina y vitamina D, cuyas deficiencias pueden estar implicadas en su aparición. En este caso, puede aprovecharse la extracción de sangre para completar con otras mediciones cuyas alteraciones no se encuentran relacionadas con las parasomnias (hepatograma, hemograma, etc.).

Un registro de polisomnografía nocturna con video conjunto es de utilidad diagnóstica en los casos frecuentes. Si se sospechan problemas de orden emocional se sugiere la consulta con un especialista.

El despertar anticipado programado (entre quince y veinte minutos antes) en los casos en que las parasomnias NO REM tengan un horario relativamente regular, es un método útil para tratarlas.

ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LA INFANCIA

Una regla mnemotécnica utilizada por los angloparlantes para abordar casos de trastornos del sueño en los niños es refiriéndose a la palabra “osos” en inglés (BEARS).

- ✓ **B:** bedtime problems (problemas en la conciliación).
- ✓ **E:** excessive daytime sleepiness (excesiva somnolencia diurna).
- ✓ **A:** awakenings during de night (despertares durante la noche).
- ✓ **R:** regularity and duration of sleep (regularidad y duración del sueño).
- ✓ **S:** snoring (ronquidos).

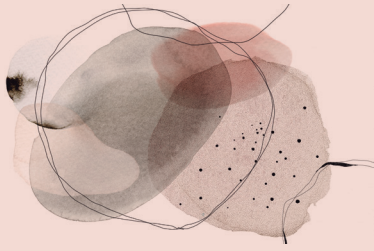
Siempre debe insistirse sobre las normas de higiene del sueño, regularidad horaria, restricción del uso de pantallas, sustancias excitantes, etc. Conservar un lugar seguro para dormir, así como evitar cualquier medicación que no sea la indicada por el médico especialista.

Conversar con los padres acerca de los mitos o creencias sobre el sueño de los niños:

- ✓ El sueño nocturno debe ser ininterrumpido.
- ✓ Los padres deben esperar a que el niño esté dormido antes de ponerlo en la cama o en la cuna.
- ✓ Los niños duermen mal por la noche si toman siestas durante el día (en horarios y con una duración adecuada).

Brindar orientaciones y consejos para padres:

- ✓ Estimule al niño a dormirse por sus propios medios.
- ✓ Establezca una rutina de sueño. Las rutinas de sueño deben incorporarse especialmente a partir de los seis meses.
- ✓ No intervenga en los despertares nocturnos para que su hijo vuelva a conciliar el sueño por sus propios medios, siempre que el niño se encuentre en condiciones saludables.
- ✓ Trate de evitar las siestas después de las diecisiete horas.
- ✓ Incorpore un objeto transicional a partir del año de vida. Deberá estar presente todo el día, no sólo en el momento de ir a dormir.
- ✓ Duerma en el mismo cuarto que el lactante durante los primeros seis meses, pero no en la misma cama.
- ✓ Los despertares incompletos durante el sueño (parasomnias NO REM) son generalmente fisiológicos y se resuelven con el transcurrir del tiempo. No intervenga demasiado, debido a que esta actitud tiende a prolongarlos.



Autoevaluación

I. Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados.

V F

1. Aproximadamente un 30% de los niños entre seis meses y cinco años tiene algún trastorno con su sueño.

☐ ☐

2. Para definir y diagnosticar un trastorno de sueño, es necesario que existan consecuencias en la calidad de su vigilia.

☐ ☐

3. Aproximadamente en un 30% de los casos existen causas médicas subyacentes a la alteración de sueño.

☐ ☐

4. A partir de los 4 años, hasta los 7 aproximadamente comienza a consolidarse el sueño nocturno con la desaparición de las siestas.

☐ ☐

5. El criterio diagnóstico más específico del insomnio pediátrico es no poder conciliar el sueño por sus propios medios.

☐ ☐

6. La mala higiene del sueño provoca una disminución del tiempo de sueño y se manifiesta durante el día con los síntomas clásicos del adulto.

☐ ☐

7. El tratamiento del insomnio infantil debe comenzar ni bien se diagnostica el cuadro para evitar el insomnio crónico.

☐ ☐

8. La prevalencia de ritmias de sueño es de alrededor del 60% durante el primer año de vida.

☐ ☐

9. Las parasomnias NO REM son las que predominan en la infancia, su prevalencia varía entre el 1 y el 4% de la población.

☐ ☐

10. Un registro de polisomnografía nocturna con video conjunto es de utilidad diagnóstica en los casos de parasomnias NO REM de muy frecuente aparición.

☐ ☐

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

1. JUANA, vuelva a leer el relato del inicio del capítulo y revise sus respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la primera presunción diagnóstica?

¿Qué conducta debe tomarse con esta familia?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. MARTÍN es un niño de dos años sano, sin antecedentes de trascendencia, cuya madre consulta porque observa movimientos rítmicos de la cabeza y el cuerpo antes de dormir, tanto de día como de noche. Duran alrededor de cinco minutos para luego conciliar el sueño. El comportamiento diurno es adecuado para la edad.

La madre le muestra un video donde se observan movimientos de tronco en el eje anteroposterior con golpeteo cefálico sobre la cama asociados a vocalizaciones y a los pocos minutos, otros en el eje laterolateral.

¿Qué presunción diagnóstica debe considerar en primer término?

¿Qué tipo de intervención es la más adecuada?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONCLUSIONES

El sueño es esencial para la salud. Es un proceso fisiológico, dinámico, complejo y reversible, que involucra a todo el organismo. Ocupa una alta proporción de la vida del niño.

Establecer rutinas regulares y hábitos saludables de sueño desde una edad temprana es crucial. Los bebés y niños pequeños se benefician de la consistencia en sus rituales de sueño, lo que puede ayudar a mejorar la calidad y la duración del sueño.

Se ha observado que las alteraciones del sueño son comunes en los primeros dos años de vida y a menudo reflejan una variabilidad normal.

Factores externos como cambios en el entorno, transiciones familiares, o enfermedades pueden contribuir a las alteraciones temporales en el sueño. Estos factores, aunque disruptivos, suelen ser manejables y no indican necesariamente un problema crónico del sueño.

Si bien es común enfrentar desafíos en el sueño durante los primeros dos años, es importante estar atento a señales que podrían indicar problemas subyacentes.

Alteraciones como las parasomnias NO REM aparecen en sueño lento profundo, con mayor frecuencia en la primera mitad de la noche y pueden desencadenarse por factores tanto internos como externos.

Cuando los trastornos del sueño se presentan con una frecuencia mayor a 3 veces por semana durante más de 3 semanas consecutivas, deben ser evaluados por el pediatra quién, junto a especialistas del sueño, eventualmente pueden ayudar a abordar posibles problemas y brindar estrategias adaptadas a las necesidades individuales del niño.

Las alteraciones del sueño en los primeros dos años de vida son comunes y en la mayoría de las veces variaciones de la normalidad. La comprensión de los patrones de sueño infantil, la adaptación a las necesidades individuales y la consulta con el pediatra son clave para brindar un entorno de sueño saludable y apoyar el desarrollo óptimo de los niños.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Gonzalo Pin Arboledas, Víctor Soto Insuga, María José Jurado Luquec Cleofe Fernandez Gomariz, Inés Hidalgo Vica-rio, Amalia Lluch Rosellof, Pedro José Rodríguez Hernández y Juan Antonio Madrid. Insomnio en niños y adolescen-tes. Documento de consenso. An Pediatr (Barc) 2017; 86 (3): 165.e1-165 e11.
- Magda Lahorgue Nunes a, Oliviero Bruni b Insomnia in childhood and adolescence: clinical aspects, diagnosis, and therapeutic approach. REVIEW ARTICLE J Pediatr (Rio J). 2015;91(6 Suppl 1): S26-S35 .
- Mindell, J.A & Owens J.A (2015). A clinical guide to pediatric sleep: diagnosis and management of sleep problems (3 rd Ed). Philadelphia, PA Wolters Kluwer.
- Hannah Wittall, Michal Kahn, Meg Pillion, Michael Gradisar. Parents matters: barriers and solutions when implemen-ting behavioural interventions for infants sleep problems. Sleep Medicine 84 (2021) 244-252.
- Jyoti Krishna MD, Maninder Kalra MD PhD; Maureen E Mc Quillar PhD. Sleep Disorders in chilhood. Pediatr Rev (2023), 44 (4): 189-202.

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Identifique Verdadero o Falso en los siguientes enunciados.

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Falso. En su mayoría tienen un origen conductual, sólo en un 5% de los casos existen causas médicas subyacentes (el síndrome de piernas inquietas, los trastornos respiratorios durante el sueño, el reflujo gastroesofágico, la alergia a la leche de vaca, entre otros).
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. Falso. En los niños son más frecuentes la irritabilidad, la hiperactividad y la inatención.
7. Falso. Los tratamientos nunca deben realizarse en menores de seis meses.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

1. JUANA

Impresión diagnóstica: mala higiene del sueño. Un insomnio causado por múltiples ingestas nocturnas y malas asociaciones del sueño.

Se debe hablar con los padres acerca de los hábitos adecuados del sueño, retirar siestas después de las diecisiete horas: sugerir que, si sigue tomando biberón por la noche, se lo den alejado de la hora de dormir y de ser posible, lo suspendan. En los despertares nocturnos crear cierta tolerancia (unos minutos) antes de ofrecerle nuevamente la mamadera. En este caso será con la fórmula diluida y con menor volumen. Noche a noche, espaciar estas mamaderas y llegar a ofrecerle, de ser necesario, exclusivamente agua.

Por otra parte, mientras se realiza el tratamiento, los padres deben completar una planilla de sueño por al menos dos semanas.

Luego, el pediatra debe citarlos para evaluar la situación y observar junto a los padres el proceso volcado en la agenda de sueño.

2. MARTIN

Usted está frente a un caso de ritmias del sueño en un niño sano. En este caso en particular esta conducta no interfiere en el comportamiento diurno del niño, de modo que sólo debe reasegurarse a los cuidadores que no son eventos patológicos. Recordarles y recomendar las normas básicas de la higiene del sueño (regularidad horaria, evitar mandarlo a la cama sin sueño, las siestas tardías), acondicionar el ambiente donde duerme para que no existan objetos con los que pueda dañarse y no al uso de chichoneras en la cuna o de colchonetas o similares sobre la pared.